

THÉRAPEUTIQUE

Fiches QE Haute Fréquence – Synthèse par leçon – V1

Cross-match : 700 QEs (2018 → 2025) × Synthèse Thérapeutique AIO (1197 pages)
14 sessions d'examen (Mai 2018 → Normal 2025) – corrections officielles

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 700 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Vaccination	56 Q	–
2	Pathologie thyroïdienne	53 Q	–
3	Migraine	48 Q	–
4	IRABC – Infections respiratoires basses	48 Q	–
5	Transplantation rénale	46 Q	–
6	Diabète	44 Q	–
7	Corticothérapie	43 Q	–
8	Épilepsie	38 Q	–
9	HTA	33 Q	–
10	Antibacillaires – Tuberculose	33 Q	–
11	Dermatologie – Dermocorticoïdes & Antiseptiques	31 Q	–
12	Asthme	31 Q	–
13	AINS	29 Q	–
14	Antibiothérapie – Principes & Échecs	28 Q	–
15	UGD & Helicobacter pylori	26 Q	–
16	OMA – Otite moyenne aiguë	25 Q	–
17	Douleur thoracique aiguë	17 Q	–
18	Angine	16 Q	–
19	SCA – Syndrome coronarien aigu	15 Q	–
20	RGO	15 Q	–
21	Sinusite & Rhinite	14 Q	–
22	IRC & troubles métaboliques	10 Q	–

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Vaccination	56	4.00	8.0%
Pathologie thyroïdienne	53	3.79	7.6%
Migraine	48	3.43	6.9%
IRABC – Infections respiratoires basses	48	3.43	6.9%
Transplantation rénale	46	3.29	6.6%
Diabète	44	3.14	6.3%
Corticothérapie	43	3.07	6.1%
Épilepsie	38	2.71	5.4%
HTA	33	2.36	4.7%
Antibacillaires – Tuberculose	33	2.36	4.7%
Dermatologie – Dermocorticoïdes & Antiseptiques	31	2.21	4.4%
Asthme	31	2.21	4.4%
AINS	29	2.07	4.1%
Antibiothérapie – Principes & Échecs	28	2.00	4.0%
UGD & Helicobacter pylori	26	1.86	3.7%
OMA – Otite moyenne aiguë	25	1.79	3.6%
Douleur thoracique aiguë	17	1.21	2.4%
Angine	16	1.14	2.3%
SCA – Syndrome coronarien aigu	15	1.07	2.1%
RGO	15	1.07	2.1%
Sinusite & Rhinite	14	1.00	2.0%
IRC & troubles métaboliques	10	0.71	1.4%
TOTAL des leçons (22 chapitres)	699 Q	49.9	99.9%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📌)

[RANG 1] VACCINATION

– • ~4.00 Q/examen (56 Q)

📖 PNI – Programme National d'Immunisation (Maroc)

BCG – un enfant vacciné par le BCG :

- Protège SURTOUT contre les formes graves (miliaire, méningite tuberculeuse), PAS à 100 %
- Risque d'effets secondaires graves (BCGite généralisée) si IMMUNODÉPRIMÉ
- Vaccin VIVANT atténué, voie intradermique, NE nécessite PAS de contrôle par IDR ni de rappel
- ▲ FAUX : « 100 % protégé contre la tuberculose »
- ▲ FAUX : « doit être contrôlé par l'IDR à la tuberculine » / « doit avoir une IDR négative »
- ▲ FAUX : « nécessite des rappels »

📖 Vu 9× : M24Q21, Jn24Q27, Nv24Q21, D24Q27, M23Q30, M22Q8, M20Q9, Jn20Q8, Jn19Q33

Vaccins VIVANTS atténués :

- BCG + Rougeole (ROR) + Polio ORALE (VPO) = vivants atténués
- Contre-indiqués chez l'immunodéprimé et la femme enceinte
- ▲ FAUX : Polio INJECTABLE (VPI) = INACTIVÉ, pas vivant
- ▲ FAUX : Hépatite B = INACTIVÉ (sous-unité), pas vivant

📖 Vu 8× : N25Q26, M24Q23, Nv24Q23, M23Q32, Jn23Q50, M20Q11, Jn20Q7, Jn19Q32

Vaccins INACTIVÉS :

- Polio INJECTABLE (VPI) + Hépatite B = inactivés
- Le pneumocoque conjugué et l'Haemophilus sont également inactivés
- ▲ FAUX : classer BCG / rougeole / polio orale parmi les inactivés

📖 Vu 2× : Jn24Q29, D24Q29

Vaccin contre le ROTAVIRUS :

- Évite PLUTÔT les formes graves (déshydratation) – n'élimine PAS la maladie diarrhéique
- Inclus au PNI, voie ORALE, fenêtre d'âge précoce (≤ 6 mois, ne se rattrape pas tard)
- ▲ FAUX : « permet d'éliminer la maladie diarrhéique »
- ▲ FAUX : « peut être donné à tout âge » / « à un enfant de 3 ans »
- ▲ FAUX : « voie injectable »

📖 Vu 7× : N25Q23, M24Q20, Nv24Q20, M23Q29, M22Q7, M20Q8, Jn19Q30

Vaccins disponibles au PNI marocain :

- Coqueluche (entier), Rotavirus, Haemophilus, Hépatite B, BCG, Pneumocoque, Polio, ROR
- Vaccin contre la ROUGEOLE = vivant atténué, inclus au PNI

- ▲ FAUX : Hépatite A – NON inclus au PNI
- ▲ FAUX : Varicelle – NON inclus au PNI
- ▲ FAUX : Oreillons isolé – donné dans le ROR, pas comme valence isolée du PNI

📖 Vu 9×+ : N25Q25, M24Q22, Nv24Q22, M23Q31, M22Q9, Jn22Q30, M21Q1, M20Q10, M18Q38

Rattrapage vaccinal (nourrisson ayant interrompu) :

- On REPREND le calendrier là où il s'est arrêté – on ne recommence PAS à zéro
- À 9 mois on peut donner DTC-Polio, rougeole (ROR) et hépatite B
- ▲ FAUX : « reprendre le programme comme s'il n'a rien reçu »
- ▲ FAUX : redonner le rotavirus en rattrapage tardif (fenêtre dépassée)

📖 Vu 3× : Jn20Q6, Jn19Q31, M18Q41

Contre-indications du BCG :

- Granulomatose septique chronique, infection VIH, déficit immunitaire combiné sévère (DICS)
- ▲ FAUX : hypotrophie et ictère physiologique NE sont PAS des CI

📖 Vu 3× : Jn22Q32, M21Q3, M18Q39

Vaccin antipneumococcique :

- Inclus au PNI, peut être administré à l'immunodéprimé, voie injectable
- Ne fait pas disparaître TOUS les cas de méningite à pneumocoque
- ▲ FAUX : « élimine tous les cas de méningite à pneumocoque »
- ▲ FAUX : « vaccin vivant » (il est conjugué/inactivé)

📖 Vu : Jn23Q47

[RANG 2] PATHOLOGIE THYROÏDIENNE

– • ~3.79 Q/examen (53 Q)

Carbimazole (Dimazol®) & Méthimazole (Thyrozol®) :

- Antithyroïdiens de synthèse (ATS) de la famille des MERCAPTO-IMIDAZOLÉS
- Indiqués pour la phase d'hyperthyroïdie ; utilisés systématiquement avant tout traitement radical (préparation à l'euthyroïdie)
- ▲ FAUX : « famille des dérivés du thio-uracile » (c'est le PTU/BTU, pas eux)
- ▲ FAUX : « traitement de l'hypothyroïdie »

📖 Vu 4×+ : N25Q4, Jn24Q4, D24Q4, Jn23Q7

L-Thyroxine (Lévothyrox®) – dose & prise :

- Dose usuelle post-op chez sujet jeune sans cardiopathie : 1,5 à 2 µg/Kg/jour
- Prise le MATIN, À JEUN, au moins 30 min avant le petit-déjeuner
- Chez coronarien et sujet âgé : dose atteinte par PALIERS progressifs
- ▲ FAUX : doses en mg/j ou en mg/Kg/j (piège d'unité – c'est µg/Kg/j)
- ▲ FAUX : « prise le soir » / « indépendante des repas »

📖 Vu 8×+ : N25Q5, Jn24Q6, M24Q7, Nv24Q7, M23Q18, M22Q18, Jn20Q19, M18Q6

Maladie de Basedow – traitement :

- ATS, posologie initiale d'attaque du Carbimazole = 20 à 40 mg/j, adaptée à l'intensité

- Bêtabloquant (propranolol) souvent associé en attendant l'effet des ATS
- Durée du traitement médical conventionnel : 12 à 18 mois
- ⚠ FAUX : posologie en mg/Kg/j (c'est mg/j)
- ⚠ FAUX : « durée ne doit pas dépasser 6 mois »
- ⚠ FAUX : « radiothérapie EXTERNE » comme traitement radical

📖 Vu : N25Q6, Jn24Q7, D24Q7

Traitement RADICAL des hyperthyroïdies :

- Irathérapie par l'IODE 131 OU thyroïdectomie totale
- L'iode 131 nécessite l'euthyroïdie préalable ; CI en grossesse et orbitopathie sévère
- ⚠ FAUX : « iode 132 » / « Technétium » (piège d'isotope – c'est le 131)
- ⚠ FAUX : « radiothérapie externe » / « chimiothérapie »

📖 Vu : M24Q8, Nv24Q8, M23Q19, M22Q19, Jn19Q11

Goitre multinodulaire toxique (GMNT) :

- Traitement radical le plus souvent : THYROÏDECTOMIE TOTALE
- Préparation systématique par ATS avant la chirurgie (obtention de l'euthyroïdie)
- Suivi post-thyroïdectomie : Lévothyrox® + dosage de la TSHus seule
- ⚠ FAUX : « irathérapie I131 » comme radical de 1er choix du GMNT (c'est la chirurgie)
- ⚠ FAUX : surveillance par LT3/LT4 (c'est la TSHus qui guide)

📖 Vu 3x+ : Jn24Q5, D24Q5, Jn23Q8 + Jn24Q6/D24Q6/Jn23Q9

Effets secondaires des ATS (mercapto-imidazolés) :

- Le plus FRÉQUENT : rash urticarien
- Le plus REDOUTÉ / grave : AGRANULOCYTOSE (NFS impérative devant toute fièvre/angine)
- ⚠ Ne pas confondre « fréquent » (rash) et « redouté » (agranulocytose)
- ⚠ FAUX : insuffisance rénale aiguë / anémie hémolytique comme effet principal

📖 Vu : M24Q9, Nv24Q9, M22Q20, M18Q5, M23Q20

Complications de la thyroïdectomie totale :

- Paralysie récurrentielle (nerf récurrent), HYP0parathyroïdie (hypocalcémie), hématome suffocant
- ⚠ FAUX : « HYPERparathyroïdie » (c'est l'HYP0 par exérèse parathyroïdienne)
- ⚠ FAUX : « AVC hémorragique » / « lésion des carotides internes »

📖 Vu : Jn19Q10

[RANG 3] MIGRAINE

– • ~3.43 Q/examen (48 Q)

Traitement SPÉCIFIQUE de la crise = TRIPTANS :

- Élétriptan (Relpax®), Rizatriptan, Sumatriptan... = traitement spécifique de la crise

- Pris DÈS le début de la céphalée ; vasoconstricteurs ; dose minimale efficace ; combinables aux AINS
- ⚠ CI : cardiopathie ischémique / coronaropathie, HTA non contrôlée, migraine hémiplégique, migraine du tronc cérébral
- ⚠ FAUX : « pris à la FIN de la céphalée » (c'est au début)

📖 Vu : M24Q15, Nv24Q15, Jn24Q21, D24Q21, M21Q50, M20Q45

Traitement NON spécifique de la crise (antalgiques/AINS) :

- AINS : Ibuprofène, Naproxène, Diclofénac ; + Aspirine et Paracétamol
- Chez la femme enceinte : PARACÉTAMOL en 1re intention
- ⚠ FAUX : Étoricoxib (coxib) comme traitement non spécifique de la migraine
- ⚠ FAUX : Amitriptyline/Topiramate en crise (ce sont des traitements de FOND)

📖 Vu : N25Q11, M24Q14, Jn24Q23, D24Q23, Nv24Q14

Traitement de FOND / préventif – indications :

- Migraines fréquentes et handicapantes, échec du traitement de crise, risque d'abus médicamenteux
- Durée 6 à 12 mois, sevrage progressif, réintroduction si récurrence
- ⚠ FAUX : « indiqué dans la migraine avec aura » comme critère à lui seul

📖 Vu : Jn24Q22, D24Q22, Jn23Q20, Jn22Q18

Choix du traitement de FOND selon le terrain :

- HYPERTENDU → PROPRANOLOL (bêtabloquant) en 1re intention
- DÉPRIMÉ → AMITRIPTYLINE (Laroxyl®)
- Autres : Topiramate, anticorps monoclonaux anti-CGRP
- Propranolol/Topiramate prescrits 3 à 6 mois
- ⚠ FAUX : Carbamazépine / Gabapentine / Lévétiracétam comme traitement de fond de la migraine

📖 Vu : Jn24Q20, D24Q20, N25Q13, M23Q37

LASMIDITAN (nouvelle molécule de crise) :

- Efficacité comparable aux triptans, agit sur la voie CGRP, voie orale, bien toléré
- Intérêt : PAS de vasoconstriction → utilisable si pathologie cardiovasculaire
- ⚠ FAUX : « contre-indiqué en cas de pathologie cardiovasculaire » (c'est justement son avantage)

📖 Vu 4x : M24Q19, Nv24Q19, Jn23Q15, M21Q46

[RANG 4] IRABC – INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES COMMUNAUTAIRES

– • ~3.43 Q/examen (48 Q)

Bronchite aiguë NON compliquée :

- Traitement SYMPTOMATIQUE : antipyrétique + vitamine C – PAS d'antibiotique d'emblée
- Antibiotique justifié SEULEMENT si : fièvre > 38,5–39 °C persistante OU OMA purulente associée

- ▲ FAUX : « antibiothérapie systématique »
- ▲ FAUX : Amoxicilline / Amox-clav d'emblée dans la bronchite simple
- ▲ FAUX : corticoïdes inhalés dans la bronchite aiguë

📖 Vu : N25Q33/35, M24Q40, Nv24Q40, Jn24Q34/35, D24Q34/35, Jn23Q23/24

Pneumonie à pneumocoque, sujet jeune SANS comorbidité :

- AMOXICILLINE 1re intention, 3 g/jour (1 g × 3)
- Enfant : Amoxicilline 100 mg/Kg/j en 3 prises
- ▲ FAUX : Amox-clav / C3G / fluoroquinolone / macrolide en 1re intention chez le jeune sain
- ▲ FAUX : « 2 g/jour » (la cible adulte est 3 g/j)

📖 Vu 4×+ : M24Q43, Jn24Q38, Nv24Q43, D24Q38, N25Q38, M18Q40

Pneumonie avec COMORBIDITÉS / sujet âgé :

- AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1re intention (1 g × 3/j)
- Pneumonie atypique suspectée → macrolide (azithromycine) ou fluoroquinolone respiratoire
- ▲ FAUX : amoxicilline seule chez le patient à comorbidités

📖 Vu : N25Q37, Jn23Q27, M20Q13, M23Q24

Critères d'HOSPITALISATION d'une pneumonie (CRB-65) :

- Confusion, FR > 30 cpm, PA basse (PAS<90 / PAD≤60), Âge ≥ 65 ans
- Évaluer aussi conscience, FC, FR, TA, terrain
- ▲ FAUX : « âge < 65 ans » comme critère de gravité
- ▲ FAUX : la seule opacité radiologique ne décide pas l'hospitalisation

📖 Vu : N25Q34, Jn23Q26, M20Q12, M18Q11

Exacerbation de BPCO – LÉGÈRE vs SÉVÈRE :

- LÉGÈRE : bronchodilatateurs ± antibiotique SI expectorations purulentes (Amox-clav, lévofloxacine, moxifloxacine)
- SÉVÈRE : antibiothérapie + bronchodilatateurs + corticothérapie systémique + oxygénothérapie ± ventilation
- ▲ FAUX : antitussif dans l'exacerbation de BPCO
- ▲ FAUX : amoxicilline seule pour l'exacerbation bactérienne de BPCO

📖 Vu 4×+ : M24Q41/42, Jn24Q36/37, Nv24Q41/42, D24Q36/37, Jn23Q25, Jn20Q30

Prévention des IRABC :

- Sevrage tabagique, vaccination (antigrippale + antipneumococcique), lavage des mains, port du masque, correction des comorbidités
- ▲ FAUX : « antibiothérapie prophylactique chez les BPCO » / « lors des bronchites aiguës »

📖 Vu : N25Q39, M20Q14

[RANG 5] TRANSPLANTATION RÉNALE

– • ~3.29 Q/examen (46 Q)

Généralités sur la transplantation rénale :

- Meilleur traitement de l'IRC terminale, améliore qualité de vie et survie, coût moindre que la dialyse à long terme
- Nécessite un traitement immunosuppresseur À VIE, une évaluation immunologique et un suivi au long cours
- Greffon implanté en FOSSE ILIAQUE ; anastomose veineuse sur la veine iliaque ; sonde JJ urinaire
- ⚠ FAUX : « immunosuppresseur uniquement la 1re année »
- ⚠ FAUX : « néphrectomie systématique du rein natif » du receveur
- ⚠ FAUX : « aucun suivi après la greffe » / « expose à une surmortalité »

📖 Vu 4×+ : N25Q47, M24Q1, Nv24Q1, Jn22Q34, M21Q6, Jn20Q20

Traitement immunosuppresseur :

- Objectif : prévenir le rejet aigu ET la dysfonction chronique du greffon
- Repose sur une ASSOCIATION de plusieurs molécules (pas une monothérapie)
- Comporte une phase d'INDUCTION puis une phase de MAINTENANCE ; équilibre efficacité/toxicité, posologie individualisée
- ⚠ FAUX : « monothérapie » / « corticothérapie seule »
- ⚠ FAUX : « posologie standard fixe identique chez tous »
- ⚠ FAUX : « uniquement par voie injectable »

📖 Vu : M24Q4, Nv24Q4, Jn22Q37, M21Q8, M20Q4

Complications fréquentes :

- Thrombose vasculaire, complications INFECTIEUSES, REJET
- ⚠ FAUX : « perforation d'ulcère » et « complications psychiatriques » parmi les complications fréquentes

📖 Vu 4× : N25Q49, M24Q3, Nv24Q3, Jn22Q36

Cadre légal & organisation au Maroc :

- Régulée par un texte de loi, autorisée UNIQUEMENT dans les structures accréditées
- Consentement éclairé du couple donneur-receveur obligatoire ; cross-match NÉGATIF requis avant greffe
- Bons résultats avec bonne survie patients/greffons
- ⚠ FAUX : « peut être réalisée dans toutes les structures »
- ⚠ FAUX : « cross-match POSITIF avant la greffe »
- ⚠ FAUX : « concerne uniquement le donneur vivant » (le don sur mort encéphalique est prévu)

📖 Vu : Jn24Q12/13/14, D24Q12/13/14, M21Q7, M20Q1

Contre-indications ABSOLUES :

- Cancer évolutif, infection mal contrôlée, maladie psychiatrique grave non contrôlée
- ⚠ FAUX : « maladie hypertensive » / « diabète » / « âge 65 ans » comme CI absolues

📖 Vu : Jn20Q21

[RANG 6] DIABÈTE

METFORMINE :

- Corrige l'INSULINORÉSISTANCE (potentialise l'insuline au foie/muscle), n'augmente PAS l'insulinosécrétion
- Dose maximale ≈ 3000 mg/j ; CI si IR sévère (risque d'acidose lactique), prudence > 75 ans
- ⚠ FAUX : « stimule la sécrétion d'insuline »
- ⚠ FAUX : « diminue l'absorption intestinale des sucres » (c'est l'acarbose)
- ⚠ FAUX : « fuite rénale de glucose » (c'est les *iSGLT2*) ; FAUX : dose d'initiation 4000 mg/j

📖 Vu : N25Q1, M24Q11, Nv24Q11

Antidiabétiques INSULINOSÉCRÉTEURS :

- Sulfamides hypoglycémiants, Glinides, inhibiteurs DPP-4, analogues du GLP-1 → induisent une insulinosécrétion
- Insuline = apport exogène (corrige le manque d'insuline)
- ⚠ FAUX : *iSGLT2* = insulinosécréteurs (ils agissent au rein, indépendamment de l'insuline)

📖 Vu : N25Q2, Jn24Q2, D24Q2, M23Q17, M24Q12, Nv24Q12

GLINIDES :

- Insulinosécréteurs à DEMI-VIE COURTE, prise conditionnée par le repas
- CI en cas d'insuffisance hépatique sévère
- ⚠ FAUX : « demi-vie longue de 12 h »
- ⚠ FAUX : « contre-indiqués dans l'IR modérée » (utilisables, contrairement aux sulfamides)

📖 Vu : Jn24Q3, D24Q3, M18Q3

iSGLT2 (gliflozines) :

- Diminuent la réabsorption rénale du glucose → glucosurie (fuite rénale de glucose)
- Risques : infections uro-génitales, hypotension, déshydratation par pollakiurie
- ⚠ FAUX : « stimulent la sécrétion d'insuline »
- ⚠ FAUX : « prise de poids importante » (ils font plutôt maigrir) ; FAUX : hypoglycémies sévères (seuls)

📖 Vu : Jn20Q14, Jn20Q15

Insulinothérapie dans le DT2 – initiation :

- Indiquée après ÉCHEC du traitement oral
- Débute par UNE injection d'analogue LENT à dose faible (0,1-0,2 UI/Kg/j) en association à metformine ± insulinosécréteur
- Titration : adapter sur la glycémie à jeun, augmentation tous les 3 jours
- ⚠ FAUX : « d'emblée 4 injections/j » / « par pompe d'emblée »
- ⚠ FAUX : « dose d'initiation 2 UI/Kg/j »
- ⚠ FAUX : « prescrite dès la découverte du DT2 car vitale »

📖 Vu : M24Q13, Nv24Q13, Jn19Q14, M18Q4

Objectifs glycémiques :

- DT1 : glycémie préprandiale 0,80-1,20 g/l, HbA1c $\approx$ 7 %
- DT2 : HbA1c < 7 % ; sujet > 75 ans : HbA1c < 8 % (objectif assoupli)
- ⚠ FAUX : initier l'insuline du DT1 à 3-4 UI/Kg/j (dose basale $\approx$ 0,3-0,4 UI/Kg/j)
- ⚠ FAUX : « HbA1c < 6 % » comme cible standard

📖 Vu : N25Q3, Jn23Q11, M18Q1, Jn19Q15

[RANG 7] CORTICOTHÉRAPIE

- • ~3.07 Q/examen (43 Q)

Surveillance clinico-biologique sous corticothérapie :

- Rechercher : HYPERglycémie, HYPERcholestérolémie, HYPERtriglycéridémie, HTA
- Surveiller aussi le risque infectieux et la kaliémie (risque d'HYPOkaliémie)
- ⚠ FAUX : « HYPERkaliémie » (le corticoïde donne plutôt une HYPOkaliémie)
- ⚠ FAUX : « hypotension » / « hypoglycémie »

📖 Vu : M24Q38, Nv24Q38, M20Q43, M23Q49, M22Q38

Choix de la molécule pour une corticothérapie ORALE au long cours :

- PREDNISONE (ou prednisolone) = molécule de référence au long cours
- Prise de la TOTALITÉ de la dose le MATIN (respect du cycle physiologique)
- ⚠ FAUX : hydrocortisone / dexaméthasone / bétaméthasone pour le long cours (réservées à d'autres indications)
- ⚠ FAUX : « fractionnement en 3 prises » / « prise le soir »

📖 Vu : M23Q47, M22Q36, M22Q37

MYOPATHIE cortisonique :

- Atteinte musculaire PROXIMALE, SYMÉTRIQUE, indolore ; CPK normales ou peu élevées
- EMG : tracé myogène sans activité ; récupération lente ; prévention = travail musculaire
- ⚠ FAUX : « déficit DISTAL »
- ⚠ FAUX : « atteinte douloureuse » / « atteinte asymétrique »
- ⚠ FAUX : « CPK très augmentées »

📖 Vu : M24Q39, Nv24Q39, M20Q44, Jn19Q45

Mécanisme & effet immunitaire des corticoïdes :

- Inducteurs de l'APOPTOSE des lymphocytes, diminuent la prolifération des LT, effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur
- ⚠ FAUX : « stimulent la prolifération des LB » / « augmentent les immunoglobulines »
- ⚠ FAUX : « effet inflammatoire » / « effet allergisant »

📖 Vu : Jn24Q48, D24Q48, M18Q34

Effets indésirables au long cours :

- Atrophie surrénalienne, diabète cortico-induit, HTA, OSTÉOPOROSE, hypogammaglobulinémie, infections

- Sevrage de l'hydrocortisone pour prévenir l'insuffisance surrénalienne au sevrage
- ⚠ FAUX : « HYPERcalcémie » (risque plutôt d'ostéoporose/hypocalcémie)
- ⚠ FAUX : « hyperthyroïdie »

📖 Vu : M23Q50, M18Q35, Jn20Q44

Prévention de l'ostéoporose cortisonique :

- Apport phospho-calcique + vitamine D suffisants, lutte contre la sédentarité, éviction du tabac
- Ostéodensitométrie ; traitement anti-ostéoporotique selon T-score $\leq -2,5$ ou FRAX
- ⚠ FAUX : « apport en protéines sans importance »

📖 Vu : N25Q9/10, M18Q28

[RANG 8] ÉPILEPSIE

– • ~2.71 Q/examen (38 Q)

Choix de l'antiépileptique selon le SYNDROME :

- Absence (enfant) → VALPROATE de sodium (éthosuximide aussi)
- Épilepsie myoclonique juvénile → VALPROATE de sodium
- Épilepsie FOCAL symptotique → CARBAMAZÉPINE (ou lévétiracétam)
- ⚠ FAUX : Carbamazépine dans l'absence / la myoclonie (peut les aggraver)
- ⚠ FAUX : Gabapentine / Phénobarbital en 1re intention de ces syndromes

📖 Vu : N25Q14, M20Q47, M24Q17, Nv24Q17, Jn24Q24, D24Q24

Antiépileptiques pendant la GROSSESSE :

- LAMOTRIGINE et LÉVÉTIRACÉTAM = les mieux tolérés / privilégiés
- VALPROATE = à proscrire (térogène : anomalies du tube neural, troubles neurodéveloppementaux)
- ⚠ FAUX : Valproate (surtout à forte dose) chez la femme enceinte
- ⚠ Carbamazépine/Phénytoïne : à éviter si alternative possible

📖 Vu : M24Q18, Nv24Q18, M23Q39, M22Q31

Bilan PRÉ-thérapeutique du VALPROATE :

- Bilan HÉPATIQUE (hépatotoxicité) + numération plaquettaire ; calcémie
- Surveillance du poids et des transaminases
- ⚠ FAUX : « glycémie / ECBU / kaliémie » comme bilan clé du valproate (c'est le bilan HÉPATIQUE qui prime)

📖 Vu 3x : N25Q16, Jn20Q28, Jn19Q19

Antiépileptiques CLASSIQUES vs nouveaux :

- Classiques : Carbamazépine, Valproate, Phénobarbital, Phénytoïne
- Nouveaux : Lévétiracétam, Lamotrigine, Gabapentine, Topiramate
- ⚠ FAUX : classer le Lévétiracétam parmi les « classiques »

📖 Vu : Jn24Q25, D24Q25

[RANG 9] HTA – HYPERTENSION ARTÉRIELLE

– • ~2.36 Q/examen (33 Q)

Bithérapie de 1re intention (ISH 2020 / ESC) :

- Association de base : IEC (ou ARA II) + INHIBITEUR CALCIQUE (ou + diurétique thiazidique)
- HTA grade ≥ 2 ou haut risque CV : bithérapie d'emblée
- ⚠ FAUX : associer IEC + ARA II (double blocage du SRA déconseillé)
- ⚠ FAUX : diurétique de l'anse comme antihypertenseur de fond (sauf IR/IC)

📖 Vu : Jn23Q5, M22Q14, M18Q20

Effets indésirables des IEC :

- Toux sèche, hyperkaliémie, élévation de la créatininémie (surveiller fonction rénale + kaliémie)
- Devant une dégradation rénale + hypokaliémie sous IEC → évoquer une cause RÉNOVASCULAIRE (sténose des artères rénales)
- ⚠ FAUX : « hypokaliémie » comme effet propre de l'IEC (il donne une HYPERkaliémie)
- ⚠ FAUX : « allongement du PR »

📖 Vu : Jn23Q4, M20Q33

Indications des BÊTABLOQUANTS dans l'HTA :

- Fibrillation atriale, angor d'effort, post-infarctus, dissection aortique
- ⚠ Prudence/CI relative : asthme non contrôlé, BPCO ; ne pas associer BB + vérapamil/diltiazem

📖 Vu : Jn23Q6

HTA RÉSISTANTE :

- Ajout de SPIRONOLACTONE à la dose de 25 mg en 4e ligne (après trithérapie incluant un diurétique)
- ⚠ FAUX : spironolactone « 50 / 75 / 100 mg » d'emblée (la dose de référence ici est 25 mg)

📖 Vu : M23Q9

Mesures hygiéno-diététiques & objectifs :

- Sel < 6 g/j, réduction pondérale, activité physique ; cible PAS souvent 130-139 mmHg (130 si bien toléré)
- Diabétique : cible PA 130/80, HbA1c < 7 %, LDL < 1 g/l ; statine si risque élevé
- ⚠ FAUX : « sel < 4 g/j » comme recommandation standard

📖 Vu : M21Q33, Jn20Q50

[RANG 10] ANTIBACILLAIRES – TUBERCULOSE

– • ~2.36 Q/examen (33 Q)

Régimes thérapeutiques (RHZE) :

- Tuberculose pulmonaire commune ET pleurale : 2RHZE / 4RH (6 mois)
- Tuberculose OSTÉO-ARTICULAIRE et NEUROMÉNINGÉE : 2RHZE / 7RH (9 mois)
- ⚠ FAUX : « 4RHZE/2RH » / « 2RHZ/4RHE » pour la TB commune (l'ordre R-H-Z-E et la durée 2/4 comptent)
- ⚠ Piège pleurale : c'est 2RHZE/4RH (6 mois), pas 9 mois

📖 Vu 4×+ : M24Q47, Jn24Q42, Nv24Q47, D24Q42, N25Q42, Jn23Q30

Posologies des antibacillaires (mg/Kg/j) :

- Rifampicine 10 mg/Kg/j • Isoniazide 5 mg/Kg/j • Pyrazinamide 25-30 • Éthambutol 15-20
- ERIPK4 (forme combinée) chez un adulte ≈ 55-70 Kg : 4 comprimés/j en 1 prise
- ⚠ FAUX : Rifampicine 5 mg/Kg/j (c'est 10) ou Isoniazide 10 mg/Kg/j (c'est 5)

📖 Vu 4×+ : M24Q49, Jn24Q44, Nv24Q49, D24Q44, N25Q41/43, Jn23Q31

Modalités de prise :

- À JEUN, 30 min AVANT le repas, en PRISE UNIQUE quotidienne, dose adaptée au poids
- ASSOCIATION de plusieurs antibacillaires (≥ 4 en phase initiale)
- ⚠ FAUX : « après le repas » / « 2-3 fois par jour »

📖 Vu 4×+ : M24Q50, Jn24Q45, Nv24Q50, D24Q45, M22Q28

Justification de l'ASSOCIATION (biologie du BK) :

- Existence de mutants naturellement résistants → association pour prévenir la résistance
- Multiplication LENTE → prise unique quotidienne suffisante ; populations intra/extracellulaires
- ⚠ FAUX : « germe anaérobie » / « purement extracellulaire » / « multiplication rapide »

📖 Vu : N25Q40, M20Q17

RIFAMPICINE – particularités :

- INDUCTEUR enzymatique → diminue l'effet des corticoïdes, des œstroprogestatifs et des AVK
- CI : accident immuno-allergique majeur antérieur, obstruction des voies biliaires, porphyrie
- ⚠ FAUX : « augmente l'effet anticoagulant des AVK » (l'induction le DIMINUE)
- ⚠ FAUX : « contre-indiquée pendant la grossesse » (elle est utilisable)

📖 Vu : M18Q9, Jn22Q46

[RANG 11] DERMATOLOGIE – DERMOCORTICOÏDES & ANTISEPTIQUES

– • ~2.21 Q/examen (31 Q)

Choix du dermocorticoïde selon la localisation/lésion :

- Visage / nourrisson (eczéma des joues) → corticoïde FAIBLE : Désonide (Locapred®/Locatop®)

- Kératodermie palmo-plantaire psoriasique / lésions épaisses → corticoïde TRÈS FORT : Clobétasol (Dermoval®), Bétaméthasone dipropionate (Diprolène®)
- ⚠ FAUX : clobétasol/Diprolène sur le VISAGE ou chez le NOURRISSON (atrophie cutanée)
- ⚠ Règle : puissance adaptée au site (faible sur peau fine, fort sur peau épaisse)

📖 Vu : M18Q7, M18Q8, Jn19Q35

ANTISEPTIQUES – Bétadine® (povidone iodée) :

- Povidone iodée ; CI chez la femme ENCEINTE et le NOUVEAU-NÉ (risque thyroïdien)
- Soins de l'ombilic du nouveau-né : éosine, chlorhexidine (PAS d'iode)
- ⚠ FAUX : « utilisable chez la femme allaitante / le nouveau-né »
- ⚠ FAUX : « bactériostatique » (la povidone iodée est bactéricide)

📖 Vu : Jn19Q34, Jn20Q11, Jn19Q36

Intertrigo inter-orteils macéré (mycose) :

- Antifongique en poudre (asséchant) : nitrate d'isoconazole (Mycoderme® poudre)
- ⚠ FAUX : dermocorticoïde seul / acide fusidique en 1re intention sur un intertrigo mycosique macéré

📖 Vu : Jn19Q35

[RANG 12] ASTHME

– • ~2.21 Q/examen (31 Q)

Traitement de fond selon la fréquence des symptômes (GINA) :

- Symptômes rares ($\leq 2 \times$ /mois) → CSI-formotérol À LA DEMANDE (palier 1)
- Symptômes $\geq 1 \times$ /semaine sans être quotidiens → CSI faible dose en fond ($\pm$ à la demande)
- Symptômes quasi quotidiens / nocturnes → ASSOCIATION CSI + BDLA (LABA) en fond
- ⚠ FAUX : BDLA (LABA) SEUL en traitement de fond (jamais sans corticoïde inhalé)
- ⚠ FAUX : corticothérapie ORALE au long cours comme fond de l'asthme courant

📖 Vu 4x+ : M24Q44/45, Jn24Q39/40, Nv24Q44/45, D24Q39/40, N25Q44/45

Traitement de la CRISE / exacerbation :

- Crise SÉVÈRE : $\beta 2$ -mimétique de COURTE durée en NÉBULISATION + corticoïde SYSTÉMIQUE (IV/oral) + oxygénothérapie
- Crise modérée : $\beta 2$ -CDA nébulisé + corticothérapie orale
- ⚠ FAUX : BDLA (LABA) nébulisé dans la crise
- ⚠ FAUX : corticoïde INHALÉ comme traitement de la crise sévère (il faut le systémique)

📖 Vu 4x+ : M24Q46, Jn24Q41, Nv24Q46, D24Q41, N25Q46, Jn22Q45

Principe d'association CSI + LABA :

- Les $\beta 2$ -mimétiques de longue durée doivent TOUJOURS être associés à un corticoïde inhalé

- CSI faible dose indiqués dès l'asthme persistant léger ; éducation + éviction des facteurs + sevrage tabagique
- ⚠ FAUX : « LABA seul en 1re intention »
- ⚠ FAUX : « corticothérapie orale en traitement de fond en 1re intention »

📖 Vu : M22Q26, M20Q15, Jn23Q33

[RANG 13] AINS

– • ~2.07 Q/examen (29 Q)

AINS chez le sujet à HAUT risque (âgé, ATCD CV/AVC, IR, antiagrégant) :

- Sujet avec ATCD d'AVC/AVCI sous antiagrégant, artériopathie → AINS CONTRE-INDIQUÉS (chercher une alternative)
- Crise de goutte chez patient à comorbidités/IR avec colchicine impossible → AINS souvent CI ; alternative = corticoïde
- ⚠ FAUX : prescrire un coxib/diclofénac « quand même » en arrêtant l'antiagrégant
- ⚠ Réponse fréquente du concours : « E – aucune réponse / alternative aux AINS contre-indiqués »

📖 Vu : N25Q7/8, Jn24Q8, D24Q8, Jn23Q22

Règles de prescription dans un rhumatisme inflammatoire (spondyloarthrite) :

- AINS lors des POUSSÉES, à la dose minimale efficace, durée la plus courte, réévaluation régulière
- Voie IM courte (≈ 3 jours) puis relais ORAL ; ne pas poursuivre en rémission
- ⚠ FAUX : « AINS à vie / en continu même en rémission pour prévenir l'ankylose »
- ⚠ FAUX : « IM pendant toute la poussée / 7 jours »

📖 Vu : M24Q5, Nv24Q5, M22Q6, Jn23Q21

Facteurs de risque digestif & précautions :

- FdR : âge > 65 ans, ATCD d'ulcère, infection H. pylori, tabac, co-prescription corticoïdes/anticoagulants/aspirine
- Précautions : IPP associé, dose minimale, durée courte, évaluer fonction rénale et TA, éducation anti-automédication
- ⚠ FAUX : « l'âge JEUNE » comme facteur de risque digestif
- ⚠ FAUX : « mêmes précautions que chez le sujet jeune » pour le sujet âgé

📖 Vu : M24Q6, Nv24Q6, M23Q36, Jn22Q4, Jn19Q40

[RANG 14] ANTIBIOTHÉRAPIE – PRINCIPES & ÉCHECS

– • ~2.00 Q/examen (28 Q)

Indications d'une ASSOCIATION d'antibiotiques :

- Tuberculose, sepsis à Pseudomonas aeruginosa, fièvre chez le neutropénique → association obligatoire

- **▲ FAUX** : association systématique pour une cystite ou une pneumonie simple du sujet jeune

📖 Vu : M24Q31, Nv24Q31

Voie INTRAVEINEUSE d'emblée :

- Méningite à pneumocoque, sepsis à BGN, endocardite → voie IV
- Démarrer avant la confirmation microbiologique dans le sepsis ; ATB bactéricide
- **▲ FAUX** : voie IV pour une angine streptococcique ou une cystite simple (voie orale)

📖 Vu : Jn24Q47, D24Q47, M21Q41

Classification de l'ÉCHEC de l'antibiothérapie :

- VRAI échec lié à : la BACTÉRIE (résistance acquise, erreur d'identification), le TRAITEMENT (posologie/durée insuffisante), le FOYER (collection, corps étranger, lithiase, métastases septiques, abcès), le MALADE (immunodépression/terrain)
- FAUX échec : fièvre d'autre origine (thrombophlébite, veinite, fièvre médicamenteuse) avec régression du syndrome inflammatoire
- **▲ Une infection à Candida ou une fièvre médicamenteuse N'EST PAS un échec lié au foyer**
- **▲ Foyer profond (abcès/empyème) → drainage CHIRURGICAL, pas seulement changer d'ATB**

📖 Vu : N25Q31/32, M23Q45, M21Q43/44, M20Q30, M18Q31

Surveillance & antibiothérapie courte :

- Réévaluation systématique à 48-72 h (efficacité ET tolérance) ; ARRÊT FRANC, sans dégression
- Antibiothérapie courte : favorise l'observance, préserve l'écologie, peu coûteuse (ex : cystite simple)
- **▲ FAUX** : « arrêt par dégression progressive des posologies »
- **▲ FAUX** : antibiothérapie courte pour une arthrite septique (infection profonde = durée longue)

📖 Vu : Jn23Q43, M23Q46, N25Q31

[RANG 15] UGD & HELICOBACTER PYLORI

– • ~1.86 Q/examen (26 Q)

Éradication de H. pylori – protocole de 1re intention (sans antibiogramme) :

- 1re intention : QUADRITHÉRAPIE bismuthée (Pylera®) OU quadrithérapie concomitante
- ALLERGIE à la pénicilline → QUADRITHÉRAPIE BISMUTHÉE (sans amoxicilline)
- **▲ FAUX** : trithérapie standard amoxicilline-clarithromycine en 1re intention (résistance clarithromycine élevée)

📖 Vu : N25Q21, Jn24Q50, M23Q34, M21Q20, M20Q37

Résistances des antibiotiques anti-H. pylori :

- Cause principale d'échec : RÉSISTANCE à la CLARITHROMYCINE (et non-observance)

- AMOXICILLINE : résistance EXCEPTIONNELLE/rare
- ⚠ FAUX : « résistance fréquente à l'amoxicilline »
- ⚠ FAUX : désigner le métronidazole comme l'ATB sans résistance (c'est l'amoxicilline)

📖 Vu : Jn22Q3, M21Q21, M20Q35

IPP & cytochrome 2C19 :

- ÉSOMÉPRAZOLE et RABÉPRAZOLE : efficacité peu dépendante du polymorphisme du CYP2C19 → à privilégier
- IPP poursuivis 4 semaines après l'éradication dans l'ulcère gastrique ; contrôle d'éradication systématique
- ⚠ FAUX : « IPP pris APRÈS le repas » (les IPP se prennent AVANT le repas)

📖 Vu : Jn24Q49, D24Q49, M20Q36, M24Q37

Composition de la quadrithérapie bismuthée :

- Sous-citrate de bismuth + métronidazole + tétracycline (chlorhydrate) + IPP
- ⚠ FAUX : y inclure l'amoxicilline ou la clarithromycine

📖 Vu : Jn20Q2

[RANG 16] OMA – OTITE MOYENNE AIGÜE

– • ~1.79 Q/examen (25 Q)

Antibiotique de 1re intention :

- AMOXICILLINE en 1re intention (enfant : 80-90 mg/Kg/j)
- Alternatives : amoxicilline-acide clavulanique, céfuroxime axétil (selon contexte)
- ⚠ FAUX : moxifloxacin / cotrimoxazole / ciprofloxacine en 1re intention de l'OMA

📖 Vu 5x+ : M20Q19, Jn20Q36, Jn19Q24, M23Q13, M22Q46, Jn23Q35, Jn22Q50

Arsenal thérapeutique global de l'OMA :

- Antalgiques/antipyrétiques, désinfection rhinopharyngée (sérum physiologique), corticothérapie orale courte, paracentèse, mastoïdectomie (compliquée)
- ⚠ Tous ces moyens peuvent faire partie de la PEC selon la gravité (réponse « A,B,C,D,E » fréquente)

📖 Vu 6x : M24Q27, Jn24Q33, Nv24Q27, D24Q33, Jn23Q37, M21Q38

Indications de la PARACENTÈSE :

- Otite COMPLIQUÉE, otite hyperalgique, otite traînante, échec thérapeutique, nourrisson < 3 mois, déficit immunitaire
- ⚠ FAUX : paracentèse devant une otite CONGESTIVE (stade congestif = pas de paracentèse)

📖 Vu : M23Q15, M22Q48, M20Q21, Jn19Q25

Échec à 72 h (tympan bombant persistant) :

- Chercher une MAUVAISE OBSERVANCE, puis indiquer une PARACENTÈSE (documentation + drainage)
- ⚠ FAUX : mastoïdectomie ou TDM du rocher d'emblée à 72 h sans complication

[RANG 17] DOULEUR THORACIQUE AIGÜE

– • ~1.21 Q/examen (17 Q)

Indications de la THROMBOLYSE IV :

- SCA avec sus-décalage PERSISTANT du segment ST (SCA ST+), jusqu'à H12, si angioplastie non disponible à temps
- Embolie pulmonaire GRAVE avec état de choc / hypotension persistante
- ⚠ FAUX : *thrombolyse dans le SCA ST- (même à haut risque) → c'est l'angioplastie*
- ⚠ FAUX : *thrombolyse dans la dissection aortique ou la péricardite (CI absolue)*

 Vu : M24Q32, Nv24Q32, N25Q27, Jn24Q16

DISSECTION AORTIQUE – prise en charge :

- Type A → traitement MÉDICO-CHIRURGICAL (urgence chirurgicale) ; Type B → médical (BB IV, inhibiteur calcique IV)
- Objectifs : PAS < 120 mmHg et FC < 60 bpm ; angioscanner thoracique = examen de référence
- ⚠ FAUX : « traitement de la dissection type A est médical »
- ⚠ FAUX : « anticoagulation par énoxaparine/HNF systématique à l'admission » (CI dans la dissection)

 Vu : M24Q33, Nv24Q33, Jn24Q17, D24Q17, Jn22Q7/27, M23Q8

Ténecteplase (Métalyse®) – dose selon le poids :

- Dose adaptée au poids : 60–69 Kg → 35 mg ; 70–79 Kg → 40 mg ; 80–89 Kg → 45 mg
- Patient 85 Kg → 45 mg ; 65 Kg → 35 mg
- ⚠ Piège récurrent du concours : associer le bon palier de poids à la bonne dose en mg

 Vu : Jn24Q18, D24Q18, N25Q29

RIVAROXABAN dans l'embolie pulmonaire :

- Inhibiteur du facteur Xa ; schéma 15 mg × 2/j pendant 21 jours, puis 20 mg/j
- CI si DFG < 15 ml/min
- ⚠ FAUX : « inhibe le facteur II » (c'est le Xa)
- ⚠ FAUX : « 15 mg × 2/j pendant 7 jours » (c'est 21 jours)

 Vu : N25Q28

[RANG 18] ANGINE

– • ~1.14 Q/examen (16 Q)

Antibiotique de 1re intention (angine streptococcique) :

- AMOXICILLINE = traitement court de référence (6 jours)
- Enfant 10 Kg : amoxicilline 50 mg/Kg/j (ex : 500 mg en 2 prises)

- **▲ FAUX** : pénicilline V / amox-clav / céfuroxime / quinolone en 1re intention (c'est l'amoxicilline)

📖 Vu 5x+ : M24Q25, Jn24Q31, Nv24Q25, D24Q31, M21Q36, M22Q45, M18Q45

Allergie aux bêtalactamines :

- MACROLIDE en cas d'allergie aux bêtalactamines
- **▲ FAUX** : C3G ou amox-clav chez l'allergique aux bêtalactamines (allergie croisée possible)

📖 Vu : M23Q12, Jn22Q47

Pourquoi traiter l'angine streptococcique ?

- Objectif principal = prévention du RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU (RAA) et des complications post-streptococciques
- **▲ FAUX** : « parce que l'origine bactérienne est la plus fréquente » (la majorité des angines sont virales)

📖 Vu : M18Q36

[RANG 19] SCA – SYNDROME CORONARIEN AIGU

– • ~1.07 Q/examen (15 Q)

Thrombolyse dans le SCA ST+ :

- Indiquée dans le SCA ST+ jusqu'à H12, d'autant plus efficace qu'elle est précoce
- Associée à une ANTICOAGULATION + double antiagrégation ; dose de charge CLOPIDOGREL = 300 mg PER OS
- **▲ FAUX** : « pas d'anticoagulant associé à la thrombolyse »
- **▲ FAUX** : clopidogrel « 300 mg en IV » (la dose de charge est orale)

📖 Vu : M23Q5, Jn23Q2, D24Q16, M22Q11

Antiagrégants & anticoagulants – classes :

- Antiagrégants plaquettaires : ASPIRINE + CLOPIDOGREL (et autres inhibiteurs P2Y12)
- AOD (anticoagulant oral direct) : APIXABAN, rivaroxaban (l'énoxaparine est une HBPM, le Sintrom® un AVK)
- **▲ FAUX** : classer héparine / bêtabloquant / digitalique parmi les antiagrégants
- **▲ FAUX** : Sintrom® / énoxaparine / aspirine comme « AOD »

📖 Vu : M23Q6, Jn23Q3

Objectif lipidique après un SCA :

- Cible LDL-cholestérol < 0,55 g/l (et réduction ≥ 50 %) → statine de forte intensité
- **▲ FAUX** : cibles « < 0,7 g/l » ou « < 1 g/l » après SCA (la cible post-SCA est < 0,55 g/l)

📖 Vu : Jn22Q9, Jn22Q29

Ténecteplase – dose selon poids (rappel) :

- 85 Kg → 45 mg ; 65 Kg → 35 mg (cf. fiche Douleur thoracique aiguë)

- ▲ Même piège dose/poids que dans la dissection/IDM

📖 Vu : M24Q34, Nv24Q34, N25Q29

[RANG 20] RGO – REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN

– • ~1.07 Q/examen (15 Q)

Pyrosis isolé sans signe d'alarme :

- Sujet JEUNE (< 50 ans) sans signe d'alarme → IPP / antiH2 d'épreuve SANS endoscopie préalable
- Sujet > 50 ans OU signes d'alarme → ENDOSCOPIE (FOGD) en 1re intention
- ▲ FAUX : endoscopie systématique chez le jeune avec pyrosis isolé sans alarme
- ▲ Attention : si âge ≥ 50 ans → la FOGD devient la bonne réponse

📖 Vu : Jn19Q47, Jn20Q4

Œsophagite peptique SÉVÈRE :

- IPP indispensables (cicatrisation muqueuse) + mesures hygiéno-diététiques et posturales
- Traitement d'entretien par IPP si poussées fréquentes/rapprochées
- ▲ FAUX : antiH2 « efficaces dans l'œsophagite sévère » (insuffisants → IPP)
- ▲ FAUX : alginates/antiacides pour cicatriser la muqueuse (ils ne font que soulager)

📖 Vu : M23Q33, M22Q15, M24Q36

Endobrachyœsophage (Barrett) :

- IPP forte dose + SURVEILLANCE endoscopique ; risque d'ADÉNOCARCINOME œsophagien
- ▲ FAUX : « traitement chirurgical systématique » de l'EBO

📖 Vu : M21Q23

Alginates & antiH2 :

- Alginates : neutralisation locale des H⁺, pris APRÈS le repas, soulagent les symptômes intermittents
- AntiH2 : utiles dans les formes à poussées rapprochées, associables aux alginates
- ▲ FAUX : alginates « permettent la cicatrisation des lésions » (rôle purement symptomatique)

📖 Vu : M21Q22, M22Q17

[RANG 21] SINUSITE & RHINITE

– • ~1.00 Q/examen (14 Q)

Sinusite maxillaire aiguë – 1re intention :

- AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE en 1re intention
- ▲ FAUX : moxifloxacin / C1G / sulfamide / macrolide en 1re intention de la sinusite maxillaire

📖 Vu 5×+ : M24Q24, Jn24Q30, Nv24Q24, D24Q30, M21Q35, M23Q14, M20Q20

Échec ou sinusite frontale → 2e intention :

- Quinolone de dernière génération (lévofloxacin, moxifloxacin) en cas d'échec de l'amox-clav ou de sinusite frontale
- ⚠ FAUX : céphalosporine de 1re génération / cycline / aminoside en 2e intention

📖 Vu : Jn22Q48, M18Q43

RHINITE allergique – paliers :

- Intermittente minime → ANTIHISTAMINIQUE en 1re intention
- Persistante modérée à sévère → corticothérapie NASALE ± générale, immunothérapie spécifique
- ⚠ FAUX : cromones seuls en 1re intention dans les formes modérées/sévères

📖 Vu : Jn19Q23, M18Q44

[RANG 22] IRC & TROUBLES MÉTABOLIQUES

– • ~0.71 Q/examen (10 Q)

Anémie de l'IRC :

- Agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) dès Hb < 10 g/dL + correction du déficit en fer
- Cible Hb modérée (≈ 10-11,5 g/dL), éviter > 13 g/dL
- ⚠ FAUX : « démarrer les ASE quand Hb > 11,5 » / « viser Hb > 13 g/dL »
- ⚠ FAUX : « encourager les transfusions » (risque d'allo-immunisation pré-greffe)

📖 Vu : Jn19Q5

Métabolisme phosphocalcique & dyslipidémie :

- Contrôle du phosphore (< 50 mg/L), chélateurs du phosphore, 1 α -OH-vitamine D3, PTH cible 3-6× la normale
- Dyslipidémie : statine ± ézétimibe, cible LDL-C < 0,70 g/L (70 mg/dL)
- ⚠ FAUX : « éviction des statines » dans l'IRC
- ⚠ FAUX : restriction calcique stricte comme mesure principale

📖 Vu : Jn19Q6, M18Q49

Méthodes d'épuration extra-rénale :

- Hémodialyse : circulation extracorporelle, membrane (surface d'échange artificielle), abord vasculaire permanent (FAV)
- Dialyse péritonéale : diffusion-osmose, accès péritonéal permanent, ascite artificielle, continue ou intermittente
- ⚠ FAUX : l'EER « corrige les fonctions endocrines » du rein (elle remplace surtout l'épuration)
- ⚠ FAUX : hémodialyse « tous les jours » (séances périodiques, ~3×/semaine)

📖 Vu : Jn19Q7, Jn19Q8, M18Q48

Urgence : HYPERKALIÉMIE :

- Gluconate de calcium (protection myocardique), sérum bicarbonaté, sérum glucosé + insuline, résines échangeuses de K⁺

- ⚠ **FAUX** : « diurétiques thiazidiques » pour traiter l'hyperkaliémie aiguë

📄 Vu : M18Q47

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0.14% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
Question transversale / hors-thème (AVC ischémique)	1 Q	0.07

[HORS 1] QUESTION INCLASSIFIABLE – AVC ISCHÉMIQUE AVEC TRANSFORMATION HÉMORRAGIQUE

1 question – item transversal, hors chapitre thérapeutique dédié

AVC ischémique sylvien total avec infarctus hémorragique (Glasgow 9) :

- Présence d'une transformation HÉMORRAGIQUE → thrombolyse et anticoagulants CONTRE-INDIQUÉS
- Prise en charge : oxygénothérapie + rééducation motrice (mesures de soutien), unité neuro-vasculaire
- ⚠ FAUX : « thrombolyse » (CI absolue en présence d'hémorragie)
- ⚠ FAUX : « anticoagulants » (aggravent le saignement)
- ⚠ Ne pas baisser brutalement la TA en phase aiguë d'AVC ischémique

📖 Vu : M18Q15 (question isolée, non rattachée à un chapitre du module)

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS THÉRAPEUTIQUE

** PROTOCOLES & SCHÉMAS POSOLOGIQUES À RETENIR PAR CŒUR **

Tuberculose commune / pleurale	2RHZE / 4RH (6 mois)
Tuberculose ostéo-articulaire / neuroméningée	2RHZE / 7RH (9 mois)
Posologies antibacillaires	R 10 – H 5 – Z 25-30 – E 15-20 (mg/Kg/j)
L-Thyroxine post-op (sujet jeune)	1,5 à 2 µg/Kg/j, le matin à jeun
Carbimazole – attaque Basedow	20 à 40 mg/j (PAS mg/Kg/j)
Pneumonie jeune sain	Amoxicilline 3 g/j
Pneumonie comorbidités	Amoxicilline-acide clavulanique
Ténecteplase (Métalyse®)	65Kg→35mg · 75Kg→40mg · 85Kg→45mg
Clopidogrel – charge (thrombolyse SCA ST+)	300 mg PER OS
Rivaroxaban – EP	15 mg *2/j * 21 j puis 20 mg/j
Spirolactone – HTA résistante	25 mg (4e ligne)

** MOLÉCULE DE 1re INTENTION PAR INDICATION (réflexe ATB/traitement) **

Marqueur / Critère	Indication
Angine streptococcique	AMOXICILLINE (allergie → macrolide)
OMA	AMOXICILLINE
Sinusite maxillaire aiguë	AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE
Sinusite frontale / échec	Fluoroquinolone de dernière génération
Migraine – crise spécifique	TRIPTANS (dès le début de la crise)
Migraine fond – hypertendu	PROPRANOLOL
Migraine fond – déprimé	AMITRIPTYLINE
Absence / myoclonie juvénile	VALPROATE de sodium
Épilepsie focale	CARBAMAZÉPINE
Épilepsie + grossesse	LAMOTRIGINE / LÉVÉTIRACÉTAM
Corticothérapie orale au long cours	PREDNISONE (le matin)
H. pylori – 1re intention	QUADRITHÉRAPIE (bismuthée ou concomitante)
SCA ST+ (angioplastie indisponible)	THROMBOLYSE jusqu'à H12

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (à ne plus jamais rater) **

- ▲ Unités L-Thyroxine : $\mu\text{g/Kg/j}$ et NON mg/Kg/j ni $\mu\text{g/j}$.
- ▲ Iode 131 (et non 132) pour l'irathérapie ; Technétium ≠ thérapeutique.
- ▲ ATS = mercapto-imidazolés (Carbimazole/Méthimazole) ; PTU/BTU = thio-uracile.
- ▲ ES des ATS : rash = le plus FRÉQUENT, agranulocytose = le plus REDOUTÉ.
- ▲ Metformine corrige l'insulinorésistance, ne stimule PAS l'insulinosécrétion.
- ▲ iSGLT2 ≠ insulinosécréteurs (action rénale, glucosurie).
- ▲ Corticoïdes → HYPOkaliémie (pas hyper) ; jamais d'hypercalcémie.
- ▲ BCG : protège des formes graves, jamais 100 %, pas de contrôle IDR, pas de rappel.
- ▲ Rotavirus : voie ORALE, fenêtre précoce, n'élimine pas la maladie.
- ▲ Rifampicine = INDUCTEUR enzymatique → diminue AVK/corticoïdes/œstroprogestatifs.
- ▲ Thrombolyse : OUI au SCA ST+ et à l'EP avec choc ; JAMAIS dans la dissection aortique.
- ▲ Dissection type A = médico-CHIRURGICAL ; pas d'anticoagulation.
- ▲ LDL post-SCA : cible < 0,55 g/l.
- ▲ AINS : âge JEUNE n'est PAS un FdR digestif ; ATCD AVC + antiagrégant → AINS CI.
- ▲ Bronchite aiguë simple : PAS d'antibiotique (sauf fièvre > 38,5 °C ou OMA associée).
- ▲ Pyrosis du jeune sans alarme : IPP d'épreuve, pas d'endoscopie d'emblée (≥ 50 ans → FOGD).
- ▲ H. pylori : résistance à l'amoxicilline = exceptionnelle ; échec = résistance clarithromycine.
- ▲ IPP : se prennent AVANT le repas.

**** ARBRES DÉCISIONNELS & ENCHAÎNEMENTS THÉRAPEUTIQUES ****

- Asthme : ≤2/mois → CSI-formotérol à la demande → CSI faible dose fond → CSI+LABA fond → CSI forte dose+LABA → corticothérapie orale.
- Hyperthyroïdie : ATS (euthyroïdie) → traitement radical (I131 OU thyroïdectomie totale).
- DT2 : règles hygiéno-diététiques + metformine → bithérapie orale → insuline basale (après échec oral).
- Échec ATB : analyser BACTÉRIE → TRAITEMENT → FOYER → MALADE (vrai échec) vs FAUX échec (autre fièvre).
- RGO → œsophagite → endobrachyœsophage (Barrett) → adénocarcinome œsophagien (surveillance endoscopique).
- OMA sous amoxicilline, échec 72 h → vérifier observance → paracentèse.
- HTA : MHD + bithérapie (IEC/ARAII + IC ou diurétique) → trithérapie → + spironolactone 25 mg (résistante).

Cross-match 700 QEs officielles × Synthèse Thérapeutique AIO (1197 pages)
14 sessions d'examen (Mai 2018 → Normal 2025) – corrections officielles

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 22)
- ✓ Déduplication : 700 questions → patterns uniques fusionnés
- ✓ FAUX (pièges) explicites avec ▲ – le contenu à plus forte valeur
- ✓ Corrections officielles consolidées sur 14 sessions (2018→2025)
- ✓ Aide-mémoire pharmaco : protocoles, molécules de 1re intention, pièges, arbres